

sescam
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha



Castilla-La Mancha

Categoría: MÉDICO DE URGENCIA HOSPITALARIA

15 de abril de 2018

Procesos selectivos convocados mediante Resoluciones de 17/08/2017 (D.O.C.M. nº 167, de 29 de agosto), de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

INSTRUCCIONES:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Utilice bolígrafo negro o azul. Antes de comenzar, lea detenidamente las instrucciones que figuran al dorso de la "Hoja de Examen".
3. Este cuestionario consta de 100 preguntas y 5 de reserva. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
4. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "Hoja de Examen" es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.
5. Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
6. Las respuestas deberán ser marcadas en la "Hoja de Examen" teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
7. El tiempo de realización de este ejercicio es de 120 minutos. Para aquellas personas con discapacidad que hayan solicitado adaptación, la duración concreta se ha establecido según el tipo de discapacidad y de acuerdo con la normativa vigente.
8. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador. El cuestionario es propiedad del Sescam por lo que no podrá llevarse el mismo una vez finalizada la prueba.
9. No está permitido el uso de calculadora, libros, documentación, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico.
10. No olvide firmar la "Hoja de Examen" en el lugar reservado al efecto.

1. **La Ley 14/86 General de Sanidad, en su artículo 53.1, establece que las Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de:**
 - a) Participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales.
 - b) Participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales.
 - c) Participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones de consumidores.
 - d) Participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones de consumidores y de empresarios.

2. **En el ámbito de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, se consideran prestaciones de atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud:**
 - a) Los servicios o conjunto de servicios terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos
 - b) Los servicios o conjunto de servicios diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos
 - c) Los servicios o conjunto de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos
 - d) Los servicios o conjunto de servicios preventivos, diagnósticos y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos

3. **Señale la correcta:**
 - a) Las propuestas bioéticas basadas en una moral religiosa responden a la idea de bioética de máximos.
 - b) La bioética de máximos sólo puede vincularse a una concepción consensualista de la bioética.
 - c) La bioética de máximos es coherente con el carácter plural de la sociedad.
 - d) El "principalismo" es una propuesta bioética de máximos.

4. **Cual de los siguientes aspectos no se debe de tener en cuenta en relación con la Autonomía del enfermo:**
 - a) Calidad de vida.
 - b) Capacidad del paciente para tomar una decisión.
 - c) Actuación sobre menores.
 - d) Consentimiento informado.

5. **El consentimiento del paciente en las pruebas diagnósticas, en los tratamientos y en los ensayos clínicos se funda en:**
 - a) El principio de información.
 - b) El principio de no maleficencia.
 - c) El principio de beneficencia.
 - d) El principio de dignidad.

6. **En caso de agresión sexual, en urgencias debemos:**
- a) Se debe realizar una anamnesis general, prestando atención a episodios previos, y consumo de alcohol o drogas.
 - b) La ginecóloga y la forense realizarán la exploración ginecológica y la toma de muestras de interés legal.
 - c) Se debe realizar una analítica, prueba de tóxicos, test de gestación y serología de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y valorar profilaxis de VHB y VIH.
 - d) Todas son verdaderas.
7. **Ante una paciente víctima de violencia de género:**
- a) La localización más frecuente de las lesiones son fracturas o hematomas en antebrazo, por los intentos de defensa de la víctima.
 - b) Las lesiones múltiples, sobre todo si están en diferente fase de curación, deben infundir sospecha de violencia de género.
 - c) No se ha descrito violencia doméstica en hombres, tengan relación hetero y/o homosexual.
 - d) Las respuestas a) y b) son ciertas.
8. **Según el protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género del año 2012 del Ministerio de Sanidad, Servicios, Sociales e Igualdad, ante cualquier actuación sanitaria en casos de Violencia de Género, es importante siempre:**
- a) No registrar en la historia clínica la sospecha y actuaciones realizadas.
 - b) Verificar el testimonio de la mujer hablando con su agresor.
 - c) Siempre que se emita un parte de lesiones, previamente hay que valorar la seguridad de la mujer y tomar medidas de protección para minimizar el riesgo.
 - d) No indagar sobre la posibilidad de malos tratos a otros miembros de la familia o personas allegadas para mantener su seguridad.
9. **Según la Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y enfermedades endémicas de ámbito regional, no se considera enfermedad de declaración urgente con envío de datos epidemiológicos básicos desde el servicio de urgencias, una de las siguientes:**
- a) Difteria
 - b) Fiebres hemorrágicas víricas
 - c) Rabia
 - d) Varicela
10. **Se conoce como herida limpia a:**
- a) Aquella no infectada, de menos de 1 hora de evolución y en la que no existe afectación profunda
 - b) Aquella no infectada, de menos de 6 horas de evolución y en la que no existe afectación profunda
 - c) Aquella no infectada, con inmunización tetánica correcta y en la que no existe afectación profunda
 - d) Aquella no infectada, que ha recibido lavado con suero y la inmunización antitetánica adecuada a su estado vacunal.

11. En el tratamiento de las heridas es cierto que:

- a) Ante una herida a nivel de la ceja, lo primero que debemos hacer es el rasurado de la ceja cercana a la herida.
- b) Antes de limpiar la herida proceder a la anestesia local con mepivacaina al 1% (Scandicain®) con vasoconstrictor para evitar el sangrado.
- c) La lidocaína (Xylocaina®) al 1% no produce reacciones alérgicas y es más seguro.
- d) Lo primero a realizar es la limpieza y exploración de la herida, retirada de cuerpos extraños y lavado de la herida y zonas adyacentes con agua y jabón neutro.

12. Respecto a las suturas, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Usaremos un punto de colchonero horizontal en heridas con bordes sangrantes.
- b) Pautaremos profilaxis antibiótica en heridas contaminadas.
- c) Colocaremos los hilos de sutura lo más alejados de las líneas de distribución de la piel, siempre que sea posible.
- d) Las suturas discontinuas son en general más permeables que las continuas.

13. En la última década, diversos autores han intentado desarrollar escalas breves y sencillas con el fin de identificar al anciano con riesgo de episodios adversos a corto plazo tras ser dado de alta desde Urgencias. Las dos más conocidas y utilizadas son:

- a) Identification of Senior at Risk (ISAR) y el Triage Risk Screening Tool (TRST).
- b) Índice de Lawton y escala de valoración de la fragilidad geriátrica de Toledo
- c) Risk Elderly Score Emergency (ESRE) y la Elderly Severity Index (ESI)
- d) Índice de Charlson modificado para el anciano e índice de Barthel.

14. La secuencia adecuada de acciones a realizar en la reanimación cardiopulmonar básica pediátrica según las recomendaciones 2015 del European Resuscitation Council y del Consejo Español de RCP es:

- a) ¿No respira? - 2 ventilaciones de rescate – mantener abierta vía aérea - ¿no hay signos de vida? – 15 compresiones torácicas - 2 ventilaciones de rescate / 15 compresiones – Llamar al equipo de paradas/emergencias tras 5 minutos de RCP.
- b) ¿No responde? – pedir ayuda – abrir vía aérea - ¿no respira con normalidad? – 5 ventilaciones de rescate - ¿no hay signos de vida? – 15 compresiones torácicas – 2 ventilaciones de rescate / 15 compresiones – Llamar al equipo de paradas/emergencias tras 1 minuto de RCP.
- c) ¿No responde? – pedir ayuda – ¿no respira con normalidad? – 2 ventilaciones de rescate - ¿no hay signos de vida? – abrir vía aérea - 30 compresiones torácicas – 2 ventilaciones de rescate / 30 compresiones – Llamar al equipo de paradas/emergencias tras 2 minutos de RCP.
- d) ¿No responde? - ¿no respira con normalidad? – ¿no hay signos de vida? - 2 ventilaciones de rescate / 15 compresiones – Llamar al equipo de paradas/emergencias tras 1 minuto de RCP.

15. En la evaluación inicial de un paciente con traumatismo craneoencefálico en urgencias se utiliza la Escala del Coma de Glasgow, que valora y puntúa (de 3 a 15) la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. A un paciente con apertura ocular espontánea, respuesta verbal con palabras inapropiadas y que localiza el dolor:
- a) Se le asignan 14 puntos.
 - b) Se le asignan 11 puntos.
 - c) Se le asignan 13 puntos.
 - d) Se le asignan 12 puntos.
16. Ante una situación de anafilaxia en un adulto, el fármaco fundamental a administrar es:
- a) Adrenalina 0,5 ml intramuscular con una dilución 1:1000 (se puede repetir a los 5 minutos si no mejora).
 - b) Adrenalina 1 ml intramuscular con una dilución 1:1000 (se puede repetir a los 5 minutos si no mejora).
 - c) Adrenalina 0,5 ml intramuscular con una dilución 1:10 (se puede repetir a los 5 minutos si no mejora).
 - d) Adrenalina 0,5 ml intramuscular con una dilución 1:1 (se puede repetir a los 5 minutos si no mejora).
17. Con respecto a las nuevas recomendaciones de la RCP de 2015 del ERC es cierto que:
- a) La supervivencia tras una PCR inducida por asfixia es frecuente y los supervivientes tienen un deterioro neurológico grave.
 - b) El reconocimiento precoz y tratamiento inmediato con Adrenalina intramuscular son la piedra angular del tratamiento de la emergencia en la anafilaxia.
 - c) Los pacientes hipotérmicos, independientemente de su estabilidad cardiaca, deben ser trasladados directamente a un centro con capacidad de realizar Soporte Vital Extracorpóreo.
 - d) No se debe trasladar a un paciente con RCP a una sala de cateterismo.
18. Respecto al uso de Calcio en el tratamiento de la parada cardiaca, señale la respuesta INCORRECTA:
- a) Indicado en AESP (Actividad Eléctrica Sin Pulso) producida por hiperpotasemia.
 - b) Indicado en TV (Taquicardia Ventricular) sin pulso tras la tercera descarga si se obtiene acceso intravenoso.
 - c) Indicado en AESP (Actividad Eléctrica Sin Pulso) producida por sobredosis de calcioantagonistas.
 - d) Dosis de 10 ml de cloruro cálcico al 10% (6.8 mmol Ca²⁺) intravenoso.

19. Respecto a los fármacos utilizados en el tratamiento de la parada cardiaca, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) En la Fibrilación Ventricular está indicado administrar Adrenalina 1ml 1:1000 intravenosa tras la tercera descarga si se obtiene acceso intravenoso.
- b) En la Taquicardia Ventricular sin pulso está indicado administrar Amiodarona 300 mg en bolo intravenoso, tras la tercera descarga si se obtiene acceso intravenoso.
- c) En la Fibrilación Ventricular está indicado administrar Cloruro cálcico al 10%-10 ml si se obtiene acceso intravenoso.
- d) En asistolia está indicado administrar Adrenalina 1 ml 1:1000 en cuanto se obtenga acceso iv.

20. En la intoxicación por metanol se pueden utilizar como antídotos:

- a) Hidroxocobalamina y etilenglicol.
- b) Azul de metileno y etanol.
- c) Fomepizol y etilenglicol.
- d) Fomepizol y etanol.

21. Señale la falsa de las siguientes afirmaciones:

- a) Pacientes con intoxicaciones leves por monóxido de carbono y que tras la administración de O₂ al 100% estén asintomáticos y con niveles de carboxihemoglobina (COHb) <5%, pueden ser dados de alta tras unas horas en observación.
- b) Los pulsioxímetros convencionales pueden dar valores falsamente elevados de saturación de O₂ en intoxicados por CO.
- c) Los niveles de COHb hasta un 20% son normales en fumadores.
- d) La hidroxocobalamina es el único antídoto seguro y eficaz ante la sospecha de intoxicación por cianuro. Se debe usar cuando hay alteraciones neurológicas (confusión, coma, agitación, convulsiones) y presente una de los siguientes supuestos: 1- bradipnea o parada respiratoria o cardiorrespiratoria, 2- shock o hipotensión, 3- acidosis láctica.

22. ¿Cuál de las siguientes no es indicación de cardioversión eléctrica?

- a) Taquiarritmias que pueden degenerar o alternar con bradicardia como el síndrome de QT largo.
- b) Taquiarritmias que condicionen: inestabilidad hemodinámica en el paciente, angina o insuficiencia cardiaca que no responde a tratamiento farmacológico.
- c) Fibrilación auricular de comienzo reciente (menos de 48 horas) o en paciente anticoagulado con respuesta ventricular rápida.
- d) Taquicardia ventricular con pulso o taquicardia de QRS ancho con sospecha de cardiopatía (que se sospeche de origen ventricular).

23. Con respecto al shock séptico, es cierto que:

- a) El tratamiento antibiótico debe iniciarse en los primeros 30 min de atención.
- b) La primera medida general para la estabilización hemodinámica del paciente es la obtención de 1 vía central.
- c) Los objetivos en las 6 primeras horas son conseguir: PVC: 8-12 mmHg. Diuresis > 0,5 ml/Kg/h.
- d) El foco urinario es el más frecuente.

- 24. El fármaco vasoactivo de primera elección en el shock séptico es:**
- a) Dobutamina.
 - b) Dopamina.
 - c) Fenilefrina.
 - d) Noradrenalina.
- 25. Entre las medidas generalizadas de estabilización hemodinámica y soporte del paciente con shock séptico, señala la respuesta ERRONEA:**
- a) Perfusión de fluidos en forma de cristaloides o coloides para mantener una Presión Arterial media mayor o igual a 65 mmHg .
 - b) Valorar uso de dobutamina en caso de depresión miocárdica.
 - c) Si aparece diátesis hemorrágica en relación con CID (Coagulación Intravascular Diseminada) transfundir plaquetas (si < de 50.000/mm³).
 - d) Infusión de insulina para mantener glucemia < 180 mg/dl.
- 26. Respecto a la sepsis en urgencias, señale la falsa:**
- a) En el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se deben cumplir 2 o más de los siguientes criterios: temperatura central > 38°C o < 36°C, frecuencia cardíaca >100 lpm, frecuencia respiratoria >20 rpm y/o PaCO₂ <32 mmHg, leucocitos >12.000/mm³ o < 4.000/mm³ o presencia >10% de cayados.
 - b) Sepsis grave: situación clínica de sepsis asociada a disfunción de órganos, hipotensión o hipoperfusión que se traduce entre otras en: acidosis láctica, oliguria o alteración del estado mental. Es recuperable tras la reposición adecuada de fluidos.
 - c) Shock séptico: hipotensión inducida por sepsis que persiste a pesar de la reposición adecuada de fluidos y que se presenta con hipoperfusión y/o disfunción de órganos. La desaparición de la hipotensión tras instaurar tratamiento con drogas vasoactivas no invalida el criterio de shock séptico.
 - d) Entre los agentes vasopresores es de elección la noradrenalina y en pacientes sin riesgo de taquiarritmias puede considerarse la vasopresina.
- 27. Paciente de 48 años que consulta por un cuadro de fiebre, cefalea frontal intensa y sensación nauseosa de 48 horas de evolución. A la exploración física presenta un estado general conservado. Se aprecia una discreta rigidez de nuca con Signo de Kerning positivo. Ante la sospecha de meningitis se realiza PL que da salida a un líquido de aspecto claro, con proteínas 60 mg/dl, glucosa 70 mg/dl (glucosa plasmática 98 mg/dl) y células 200 con un 89% de linfocitos. ¿Cuál es la causa más probable de la meningitis en este paciente?:**
- a) Neisseria meningitidis.
 - b) Streptococcus pneumoniae.
 - c) Coxsackie.
 - d) Listeria monocytogenes.

- 28. En la evaluación inicial de todo paciente politraumatizado en coma ¿cuáles de las siguientes radiografías son imprescindibles incluso aunque dichas localizaciones no parezcan ser sintomáticas?**
- a) Rx antero-posterior de cráneo y Rx antero-posterior de pelvis.
 - b) Rx antero-posterior de tórax y Rx axial de pelvis.
 - c) Rx lateral de columna cervical y Rx anteroposterior de pelvis.
 - d) Rx lateral de columna cervical y Rx anteroposterior de columna lumbar.
- 29. La fractura diafisaria del húmero se asocia con cierta frecuencia a lesiones del nervio:**
- a) Circunflejo.
 - b) Radial.
 - c) Mediano.
 - d) Cubital.
- 30. En la neuralgia del glosofaríngeo o síndrome de Sicard, el dolor es:**
- a) Recurrente en la amígdala faríngea, paladar y parte posterior de la lengua que aumenta con la deglución. Se debe descartar la presencia de un tumor o de una compresión vascular.
 - b) Del oído por calcificación del ligamento estilomastoideo. Suele asociarse a amigdalectomía o cirugía de cuello. A la palpación se aprecia proceso estiloideo elongado bajo punta de la mastoides.
 - c) Debido a un problema centrado en la articulación o en los grupos musculares relacionados. El dolor aumenta con la masticación y con frecuencia el paciente está diagnosticado de ansiedad, bruxismo, maloclusión o fibromialgia.
 - d) Del oído, por estimulación del nervio glosofaríngeo, causado por infecciones y patología tumoral de rinofaringe, base lingual, fosa amigdalina, hipofaringe, faringe y esófago.
- 31. La fractura de Maisonneuve es una fractura espiroídea del tercio proximal del peroné asociado a una disrupción de la sindésmosis tibiofibular distal y de la membrana interósea. Está asociada a fracturas del maléolo medial o a ruptura del ligamento deltoideo profundo. ¿Por qué mecanismo lesional se produce?**
- a) Supinación y rotación externa.
 - b) Pronación y abducción.
 - c) Pronación y rotación externa.
 - d) Supinación y aducción.
- 32. La fractura de radio distal:**
- a) Es la más frecuente de la extremidad superior, afecta principalmente a mujeres entre 40 – 60 años de edad que sufren una caída con la mano en flexión dorsal.
 - b) Afecta principalmente a hombres entre 40 – 60 años de edad.
 - c) En los niños es la fractura más frecuente de todo su cuerpo.
 - d) a) y c) son ciertas.

- 33. En el esguince de tobillo, las Normas de Ottawa:**
- a) Tienen una alta sensibilidad (96,8%) y una especificidad del 45,8%
 - b) Estas reglas permitieron reducir el número de radiografías en torno a un 75%
 - c) La prueba del diapasón, no mejora la especificidad de las Normas de Ottawa
 - d) Independientemente de las Normas de Ottawa, es recomendable la realización de una radiografía de tobillo para descartar fracturas óseas asociadas.
- 34. Tras un traumatismo severo de columna vertebral, en un accidente de tráfico y para realizar la evaluación clínica del tracto corticoespinal, comprobaremos su integridad:**
- a) Por contracciones musculares voluntarias o respuesta involuntaria al estímulo doloroso
 - b) Prueba con alfiler y tacto ligero.
 - c) Sentido de posición en los dedos del pie y las manos o vibración utilizando un diapasón.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.
- 35. De los criterios de Gurd y Wilson para el diagnóstico de Síndrome de embolia grasa, cual no es un criterio mayor:**
- a) Petequias subconjuntivales y axilares.
 - b) Anemia súbita inexplicable
 - c) Insuficiencia respiratoria.
 - d) Depresión del SNC
- 36. Varón de 42 años, tallador de vidrio, que sufre quemaduras con ácido fluorhídrico al 25% en mano derecha, con un 1% de superficie corporal quemada. ¿Cuál de estas alteraciones sistémicas esperaría no encontrar?:**
- a) Hipomagnesemia acompañada de un Síndrome de QT largo.
 - b) Acidosis metabólica.
 - c) Hipercalcemia.
 - d) Hiperpotasemia.
- 37. Con respecto a las quemaduras, es cierto que:**
- a) Los pacientes con quemaduras pueden presentar shock distributivo.
 - b) Los líquidos a administrar se calculan por la fórmula de Pakland o la regla de Evans.
 - c) La regla de Beaux está basada en la localización de las quemaduras.
 - d) Las quemaduras por ácidos se tratan con neutralizante (bicarbonato sódico al 20%).
- 38. ¿Cuál de los siguientes patrones respiratorios del coma y su correspondiente localización topográfica es la denominada respiración apneútica?**
- a) Oscilación lenta y cíclica entre hiper e hipoventilación. Lesión supratentorial extensa o lesión diencefálica o en intoxicaciones.
 - b) Respiración profunda rápida y mantenida. Lesión de tronco alto y en comas metabólicos.
 - c) Bradipnea, apneas largas seguidas de inspiración profunda mantenida. Lesión de tronco bajo o en comas metabólicos.
 - d) Irregular. Lesión bulbar extensa.

- 39. Ante un paciente en coma, al explorar los movimientos o desviaciones oculares, es cierto que:**
- a) Si presenta bobbing ocular, indicará lesión protuberancial.
 - b) La convergencia de la mirada hacia abajo y adentro indicará lesión tronco cerebral.
 - c) Los movimientos erráticos oculares son indicativos de lesión talámica.
 - d) La mirada desconjugada indica lesión del III ó IV par.
- 40. En la valoración inicial de un paciente en coma, podemos encontrar patrones de respuesta pupilar. Ante unas pupilas isocóricas, mióticas y normoreactivas, cuál de las siguientes patologías esperaría NO encontrar:**
- a) Encefalopatía metabólica.
 - b) Intoxicación por insecticidas organofosforados.
 - c) Lesiones diencefálicas.
 - d) Intoxicación por cocaína.
- 41. En la valoración del paciente en coma en urgencias es importante la localización topográfica, para ello se utiliza, además del tamaño y reactividad pupilar, el patrón respiratorio. Es cierto que:**
- a) Una respiración profunda, rápida y mantenida ("respiración de Kusmaul") orienta a una lesión de tronco alto o a un coma de origen metabólico.
 - b) Una respiración de oscilaciones lentas y cíclicas entre hipo e hiperventilación ("respiración de Cheyne-Stokes") orienta a una lesión bulbar extensa.
 - c) Una respiración normal orienta a que el origen sea metabólico ("respiración dulce").
 - d) Una respiración irregular y sin patrones ("respiración atáxica de Biot") orienta a una lesión de tronco extensa (alto y bajo).
- 42. El deterioro rostrocaudal se basa en un daño progresivo de las estructuras anatómicas que conforman el encéfalo. ¿Cuál de los siguientes síndromes refleja una afectación protuberancial inferior o bulbar superior?**
- a) Trastornos respiratorios intercalando algún suspiro o de Cheyne-Stokes. Respuesta pupilar: mióticas hiporreactivas. Reflejo ciliospinal: positivo. Al pellizcar la piel del cuello se produce midriasis. Reflejo oculocefálico: positivo. Respuesta motora: coordinada al dolor Reflejo cutaneoplantar: extensor bilateral. Cierta hipertonía bilateral de todos los miembros.
 - b) Respiración de Cheyne-Stokes bien establecida. Pupilas, reflejo ciliospinal y oculocefálicos sin cambios respecto al anterior. Respuesta motora con flexión de las extremidades superiores (rigidez de decorticación).
 - c) Es una situación crítica, siendo muy poco probable que tenga buen pronóstico. Hiperventilación regular y mantenida. Pupilas en midriasis media, deformadas y arreactivas. Reflejo ciliospinal negativo. Reflejos en ojos de muñeca difíciles de obtener e incoordinados. Respuesta extensora de todas las extremidades.
 - d) Constituye el paso previo al diagnóstico de muerte cerebral. No suele mantener la respiración, a veces aguanta con una respiración superficial y rápida. Pupilas en midriasis media y arreactivas. Reflejos oculocefálicos ausentes. Reflejo ciliospinal negativo. No hay respuesta motora, aunque pueden aparecer algunas respuestas flexoras aisladas que indican liberación espinal.

43. En un paciente con EPOC y agudizaciones frecuentes que ha estado ingresado 4 veces este año con tratamiento antibiótico y corticoideo, ¿qué antibiótico le pondría si ingresa en urgencias con lo que parece una nueva agudización?
- Imipenem 1g/8h (iv) asociado a Tobramicina 5mg/Kg/día (iv)
 - Betalactámicos con acción antipseudomónica (iv). Puede asociarse aminoglucósido o fluorquinolonas (iv) en los 3-5 primeros días.
 - Las respuestas a) y b) son correctas.
 - Amoxicilina/Ac. Clavulánico 1000/125 (iv).
44. De los criterios ATS/IDSA 2007 de ingreso en UCI de las NACG (*American Thoracic Society-Infectious Diseases Society of America*. NACG: neumonía adquirida en la comunidad grave).
- Criterios mayores: Necesidad de ventilación mecánica y Shock séptico con vasopresores.
- Criterios menores:
- PAS < 90 mmHg (que requiere fluidoterapia agresiva); Afectación multilobar (2 lóbulos) o bilateral; Frecuencia respiratoria >30 rpm; Confusión/desorientación; Urea >45 mg/dl (BUN > 20 mg/dl); PaO₂/FiO₂ <250; Leucopenia < 4.000/mm³; Trombocitopenia < 100.000/mm³; Hipotermia (temperatura < 36°C)
- Se debe cumplir al menos:
- Un criterio mayor o tres menores para indicar su ingreso en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).
 - Un criterio mayor y dos menores para indicar su ingreso en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).
 - Un criterio mayor y uno menor para indicar su ingreso en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).
 - Al menos cuatro criterios menores para indicar su ingreso en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).
45. ¿Cuales son los criterios de estabilidad clínica de Halm et al. para la terapia secuencial en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC)?
- Buen nivel de conciencia y tolerancia a la vía oral.
 - FC <100; FR <24; T^a <37.2°C; PA sistólica >90; SatO₂ >90%; Buen nivel de conciencia y tolerancia vía oral.
 - FR <24; T^a <37.2°C; PA sistólica >90; SatO₂ >90%; Buen nivel de conciencia y tolerancia vía oral.
 - FC <100; FR <22; T^a <37.5°C; PA sistólica >100; SatO₂ >92%; Buen nivel de conciencia y tolerancia vía oral.
46. Con relación a las escalas pronósticas de gravedad de las neumonías:
- Tanto la escala Fine, la PSI y el CURB65 poseen una capacidad similar para reconocer a los pacientes con riesgo de fallecer a partir de los 30 días.
 - La escala PSI define 6 clases de riesgo en relación con la mortalidad a partir de los 30 días.
 - La escala FINE o PSI modificada mejora la adecuación de los ingresos en los S.U.H.
 - La escala CURB65 define 5 grupos de riesgo y está basada en la Sat O₂ y en la PaO₂.

47. Señale la pauta de tratamiento empírico intravenoso no adecuada ante un paciente con el diagnóstico de probable neumonía por aspiración:
- Ertapenem 1 gramo (g) cada 24 horas.
 - Clindamicina 600-900 mg cada 8 horas más ceftriaxona 1 g /12 horas.
 - Levofloxacin 500 mg/ 24 horas.
 - Amoxicilina-clavulánico 2/0,2 grs. cada 8 horas.
48. ¿Cuál de las siguientes son posibles causas de elevación de troponina, no secundarias a isquemia miocárdica?
- Embolia pulmonar, hipertensión pulmonar grave.
 - Enfermedad neurológica aguda, incluidos accidentes cerebrovasculares, o hemorragia subaracnoidea.
 - Síndrome de balonización apical.
 - Todas las anteriores son causa de elevación de troponina.
49. ¿En la Insuficiencia cardíaca o el Edema Agudo de Pulmón la determinación en plasma de péptidos natriuréticos (BNP, NT-proBNP) tiene mucha utilidad: ¿Cuál de las siguientes no es cierta?
- En el diagnóstico, por su alto valor predictivo negativo
 - En el seguimiento de la Insuficiencia Cardíaca crónica (valores elevados con tratamiento óptimo indican buen pronóstico)
 - En procesos hiperagudos pueden encontrarse valores normales.
 - Se puede encontrar elevación de estos péptidos en otras situaciones clínicas: hipertrofia ventricular izquierda, sobrecarga de cavidades, hipoxemia, taquicardias, insuficiencia renal, cirrosis hepática, edad avanzada, bronconeumopatía crónica, infecciones y sepsis.
50. El gradiente alveolo-arterial $[P(A-a)O_2]$ que es la diferencia entre la PAO_2 y la PaO_2 (cantidad de oxígeno alveolar transferido de los pulmones a la circulación), cuya fórmula para calcular es $P(A-a)O_2 = [(PB - PH_2O) \times FiO_2] - PaCO_2/R - PaO_2$
- PAO_2 = Presión alveolar de oxígeno.
 - PB: Presión barométrica o atmosférica: 760 mmHg a nivel del mar (en Toledo tiene un valor de 720 mmHg).
 - PH_2O : Presión desplazamiento del vapor de agua. Equivale a 47 mmHg.
 - FiO_2 : Fracción inspiratoria de oxígeno. En aire ambiente es de 0,21.
 - $R = 0,8$ (cociente respiratorio o relación entre el consumo de oxígeno y la producción de CO_2).
- Sirve fundamentalmente para:
- Determinar si estamos ante una patología intra o extrapulmonar.
 - Determinar si estamos ante una insuficiencia respiratoria severa.
 - Determinar si se trata de un barotrauma.
 - Determinar si estamos ante una insuficiencia respiratoria hipoxémica.
51. Un líquido pleural consistente en un exudado de aspecto claro, con LDH elevada, proteínas siempre por encima de 3 g/dl, glucosa < 60 mg, pH por debajo de 7,40 y células entre 1.000 y 6.000/mm³ con predominio de linfocitos (en fases agudas puede haber predominio de neutrófilos). Corresponde o nos debe hacer sospechar:
- Derrame pleural paraneumónico complicado o empiema.
 - Rotura esofágica o proceso neoplásico.
 - Tuberculosis pulmonar.
 - Insuficiencia cardíaca congestiva tratada con diuréticos.

52. **Es una contraindicación para la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI) en la Insuficiencia Respiratoria Aguda:**
- a) Inestabilidad hemodinámica.
 - b) IRA no hipercápnica con Frecuencia Respiratoria > 35.
 - c) EPOC reagudizado con $\text{PaCO}_2 > 45$ y $\text{pH} < 7,30$.
 - d) Síndrome de hipoventilación-obesidad.
53. **Con respecto a la ETEV-TVP (Enfermedad Tromboembólica Venosa – Trombosis Venosa Profunda) es cierto que:**
- a) Con un resultado de la Escala de Wells de probabilidad media y un Dímero D positivo, hay que iniciar tratamiento.
 - b) Escala de Wells de probabilidad media, hay que solicitar Dímero D.
 - c) Ante Escala de Wells de probabilidad media y Ecodoppler positivo hay que iniciar tratamiento.
 - d) Si obtenemos una escala de Wells que indica probabilidad media y el Ecodoppler es negativo, hay que solicitar Dímero D.
54. **Entre los parámetros utilizados para regular el respirador en la ventilación mecánica no invasiva cuando hablamos de “rampa” nos referimos a:**
- a) La relación entre el tiempo de inspiración e inspiración.
 - b) La velocidad a la que se aplica el flujo de oxígeno.
 - c) Diferencia en cm de H_2O entre la IPAP y la EPAP.
 - d) El aumento secuencial de 2 en 2 respiraciones por minuto de la frecuencia respiratoria impuesta por el ventilador.
55. **Señale la verdadera de las siguientes afirmaciones:**
- a) Denominamos hemoptisis masiva cuando el volumen de sangrado es mayor de 500-600 ml en 24-48 horas o supera 150 ml/hora.
 - b) En el tratamiento de la hemoptisis si se asocia a broncoespasmo se deben utilizar corticoides vía parenteral y aerosoles.
 - c) En el derrame pleural para el diagnóstico de exudado los criterios de Light tienen alta sensibilidad y baja sensibilidad.
 - d) Son verdaderas a) y c).
56. **Un motivo frecuente de consulta en urgencias es la fiebre. Cuando existe fiebre suele haber taquicardia. La existencia de una “bradicardia relativa” se encuentra en:**
- a) Fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis, legionelosis y fiebres inducidas por fármacos o facticia.
 - b) Fiebre de Pel-Ebstein en la enfermedad de Hodgkin donde vemos 3-10 días con fiebre y 3-10 días sin ella.
 - c) Fiebre palúdica donde hay recurrencias cada 72-96 horas (“terciana-cuartana”).
 - d) Todas las anteriores son correctas.

57. En la profilaxis a los contactos, en caso de un paciente con meningitis bacteriana aguda, disponemos de varias posibilidades. ¿Cuál de las siguientes no es correcta?

- a) Rifampicina (de elección): dosis de 600 mg/12 h vo durante 2 días (contraindicada en pacientes gestantes, con enfermedad hepática severa, alcoholismo, porfiria, hipersensibilidad a rifampicina o toma de anticonceptivos orales).
- b) Levofloxacino 500 mg + TMP-SMX 800/160mg: ambos en dosis única, si alergia a penicilina.
- c) Ciprofloxacino: se utilizará en dosis única de 500 o 750 mg vo. No indicada esta opción en embarazadas ni en niños.
- d) Ceftriaxona: dosis única 250 mg im en dosis única, (en niños de < 15 años 125 mg). De elección en embarazadas.

58. El tratamiento del paciente inmunodeprimido será:

- a) Infección asociada a catéter: Vancomicina 1g /12 h (iv) + Retirar catéter si es posible.
- b) Neumonía nosocomial: Levofloxacino 500 mg / 24 h (vo ó iv).
- c) Sospecha de enfermedad por citomegalovirus: Aciclovir 200 mg / 4 h (vo), durante 5-7 días en infección orogenital.
- d) En una ITU comunitaria: Cefepime 1g / 8-12 h.

59. En la Neutropenia febril, es cierto que:

- a) Es indicación de tratamiento antibiótico empírico cifras de Neutrófilos > 150/ul con cualquier signo o síntoma sugestivo de infección.
- b) Ante una cifra de Neutrófilos < 400/ul + Fiebre > 38°C hay que iniciar tratamiento antibiótico empírico.
- c) Ante un paciente con mucositis grado 3 con SAMR y neutropenia febril el tratamiento empírico será: Meropenem 1 gr. cada 8 hrs. + Vancomicina 1 gr. cada 12 hrs. (ambos iv.)
- d) Ante un enfermo con neutropenia de más de 7 días y fiebre, el tratamiento será: Imipenem 1 gr. cada 6 hrs. (iv).

60. En los pacientes cirróticos con dolor abdominal y fiebre, una de las circunstancias a descartar sería la existencia de una peritonitis bacteriana espontánea. Señale los patógenos más probables implicados en estos cuadros y la pauta antibiótica empírica indicada:

- a) Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Tratamiento: ceftriaxona o cefotaxima.
- b) Streptococcus pneumoniae y Enterococcus spp. Tratamiento: ceftriaxona o cefotaxima.
- c) Klebsiella pneumoniae y Enterococcus spp. Tratamiento: ciprofloxacino o levofloxacino.
- d) Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Tratamiento: ciprofloxacino o levofloxacino.

61. En relación al tratamiento de la ITU (Infección del Tracto Urinario):

- a) Amoxicilina/Clavulánico se considera de primera elección.
- b) La terapia secuencial para la PNA (Pielonefritis Aguda) es: Cefditoren 400 mg / 12 hrs. durante 10 días.
- c) Si hay prostatitis aguda el tratamiento es: Ceftriaxona 2 grs. (iv) * Tobramicina (5-7 mg / Kg) (iv) en dosis únicas + Cefditoren 400mg / 12 hrs. hasta los 30 días.
- d) El tratamiento de la Orquiepididimitis por sospecha de ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual) es: Ceftriaxona 2grs. (IV) + Doxicilina 100 mg vía oral.

62. En las infecciones del tracto urinario (ITUs), es falso:

- a) Una cistitis en una mujer joven sería una ITU no complicada. Uretritis, pielonefritis, y prostatitis serían ITUs complicadas.
- b) La bacteriuria asintomática no precisa tratamiento antibiótico salvo en embarazadas y procedimientos urológicos.
- c) En la cistitis aguda no complicada está indicado el tratamiento vía oral con pauta de cinco días de cefuroxima axetilo 500mg/12 horas o amoxicilina clavulánico 500 mg/8 horas.
- d) En una pielonefritis aguda comunitaria con estabilidad hemodinámica está indicado el tratamiento iv con ceftriaxona 1g en dosis única y completar el tratamiento vo durante 7-14 días con cefuroxima axetilo 500mg/12 horas.

63. Paciente de 80 años que presenta una Neuralgia del Trigémino, se desaconseja tratamiento con:

- a) Carbamacepina.
- b) Topiramato.
- c) Baclofeno asociado a Carbamacepina en caso de pérdida de eficacia de la Carbamacepina.
- d) Lamotigina.

64. Con respecto al tratamiento del dolor es falso que:

- a) Meperidina es de elección en el cólico biliar.
- b) Tapentadol está indicado en el dolor crónico intenso.
- c) Fentanilo es superior a morfina por su rápido inicio, mayor duración de acción y mayor potencia.
- d) Bupremorfina no es muy útil para el dolor agudo.

65. En el manejo práctico y control del dolor en urgencias, en ocasiones hay que recurrir al tercer escalón (según la Organización Mundial de la Salud) y utilizar opioides mayores. Una cuestión fundamental para no equivocarnos en las indicaciones y dosis administradas es conocer las equivalencias entre los distintos fármacos. Solo una de las equivalencias vía intravenosa de las mostradas es cierta:

- a) Morfina 1 mg = meperidina 100 mg = fentanilo 1 mg.
- b) Morfina 10 mg = meperidina 100 mg = fentanilo 0,1 mg.
- c) Morfina 10 mg = meperidina 1 mg = fentanilo 1 mg.
- d) Morfina 1 mg = meperidina 1 mg = fentanilo 0,1 mg.

66. En las fases finales del paciente paliativo, en ocasiones, se originan abundantes ruidos asociados a los movimientos respiratorios producidos por la oscilación de las secreciones acumuladas ("estertores premortem"). Con frecuencia causan gran angustia en los familiares. Todas las siguientes, menos una, son medidas para paliarlos:

- a) Poner en decúbito lateral, si es posible, con la cabeza elevada.
- b) Disminuir la hidratación.
- c) Butilescopolamina 20-40 mg/ 8 horas vía subcutánea.
- d) Baclofeno 5 mg/ 8 horas vía subcutánea.

67. Mujer de 30 años que consulta por aproximadamente 20 episodios al día de dolor intenso, periocular izquierdo de 15 minutos de duración, acompañada de intenso lagrimeo y rinorrea. Su exploración y resonancia magnética son normales. Su tratamiento de elección sería:

- a) Lamotrigina.
- b) Indometacina.
- c) Prednisona
- d) Verapamilo

68. Respecto al tratamiento del dolor de los pacientes en urgencias disponemos de la escalera de la OMS. Señale la falsa de las siguientes afirmaciones:

- a) Dolor leve. Primer escalón: no opioides +/- coadyuvantes. Grupo heterogéneo de fármacos entre los que se incluyen. ácido acetil salicílico, paracetamol y AINEs
- b) Dolor moderado. Segundo escalón: opioides menores +/- no opioides +/- coadyuvantes. Se incluyen: codeína, dihidrocodeína y tramadol.
- c) Dolor intenso. Tercer escalón: opioides mayores +/- opioides menores +/- no opioides +/- coadyuvantes. Se incluyen: morfina, fentanilo, oxicodona, meperidina, tapentadol, buprenorfina, hidromorfona.
- d) La teoría del ascensor analgésico, es la más utilizada en la práctica clínica y establece que en función del grado de dolor existen 4 botones, sin necesidad de pasar por cada uno de ellos de los escalones como establece la escalera original de la OMS.

69. Señale la falsa en el síndrome de vena cava superior en el paciente oncológico:

- a) El síntoma más frecuente es la disnea, puede aparecer edema en esclavina, ingurgitación yugular, inyección conjuntival, cefalea, circulación venosa colateral, tos o síncope. Los síntomas empeoran al tumbarse o al inclinarse hacia delante
- b) Es característico el signo de Botermann: cuando un paciente eleva los brazos por encima de la cabeza, aumenta la cianosis, el edema facial y la congestión cefálica.
- c) La radiografía de tórax la mayoría de las veces es normal. El TAC torácico es útil para conocer la etiología.
- d) En el tratamiento hay que usar medidas de soporte como el cabecero elevado y oxigenoterapia, el uso de los corticoides sistémicos es controvertido y la endoprótesis vascular es el tratamiento de elección.

70. El dolor abdominal agudo en los recién nacidos, no suele deberse a:

- a) Atresia intestinal.
- b) Enfermedad de Hirshprung.
- c) Ileo meconial.
- d) Estenosis hipertrófica de píloro.

- 71. Según la escala de “Sad Persons” de valoración del riesgo y gravedad del intento suicida, un paciente varón de 80 años, sin esposa, que abusa del alcohol y está diagnosticado de depresión:**
- a) Tendría una puntuación de 5 y debería indicarse su ingreso en Psiquiatría.
 - b) Tendría una puntuación de 10 y debería indicarse su ingreso en Psiquiatría.
 - c) Tendría una puntuación de 35 y debería indicarse su ingreso en Observación.
 - d) Tendría una puntuación de 10 y debería indicarse su seguimiento ambulatorio con control estrecho y frecuente.
- 72. Ante un paciente psiquiátrico con ansiedad, cuál de las siguientes afirmaciones considera que es falsa:**
- a) Ante un cuadro intenso de ansiedad, tener en cuenta la posibilidad de proceso orgánico agudo, intoxicación o abstinencia.
 - b) Cuando los síntomas son similares a los de un proceso coronario, manejar al paciente como si los síntomas fueran de origen cardíaco.
 - c) Los trastornos epilépticos pueden producir cualquier síntoma psiquiátrico, incluida la ansiedad.
 - d) La ansiedad es más rara en ancianos, afectando a menos del 5%.
- 73. En el manejo del paciente agitado en urgencias, además de medidas generales de seguridad, contención verbal y mecánica, usamos los neurolépticos como parte del tratamiento farmacológico.**
- a) El haloperidol puede producir convulsiones o extrapiramidalismo.
 - b) El haloperidol y la levomepromacina están contraindicados en intoxicaciones etílicas, y depresión de SNC.
 - c) La ziprasidona, al ser un neuroléptico atípico, tiene mejor tolerancia y menor incidencia de efectos adversos.
 - d) Todas son verdaderas.
- 74. Respecto al uso de la ecografía abdominal como exploración complementaria en el dolor abdominal agudo, es el método de elección en todos los casos siguientes, EXCEPTO:**
- a) Patología de la vesícula y vía biliar.
 - b) Patología urológica.
 - c) Patología retroperitoneal
 - d) Patología ginecológica.
- 75. De las siguientes afirmaciones respecto al protocolo ECO-FAST, señale la falsa:**
- a) Es una ecografía abdominal dirigida a localizar líquido libre en la cavidad peritoneal, que se ve como una imagen hiperecoica.
 - b) Se exploran cuatro áreas: pélvica, perihepática, periesplénica y pericárdica.
 - c) Las áreas perihepáticas y periesplénicas se exploran con la sonda en posición coronal a nivel de flanco.
 - d) El área pélvica se explora con la sonda en posición transversal por encima de la sínfisis del pubis y el área pericárdica con la sonda en posición subxifoidea dirigida al hombro izquierdo.

76. El protocolo FAST, propone la exploración del abdomen en 4 zonas, señale cuál de ellas NO es correcta:

- a) El espacio de Morrison.
- b) El receso esplenorrenal.
- c) El saco pericárdico.
- d) Región pleural anterior bilateral.

77. Entre las utilidades de la ecografía pulmonar en urgencias se encuentra el detectar la existencia de un neumotórax. La pleura es fácilmente reconocible como una línea hiperecoica entre dos sombras posteriores, proyectadas por dos costillas adyacentes. Señale la cierta:

- a) Se conoce como "*sliding*" al efecto visual a modo de un suave movimiento o deslizamiento pleural con la respiración y su presencia sugiere la existencia de un neumotórax.
- b) Se conoce como "*sliding*" la visión de una zona hiperecogenica que descarta un derrame pleural.
- c) Se conoce como "*sliding*" la visión de una zona hiperecogenica que sugiere un derrame pleural.
- d) Se conoce como "*sliding*" al efecto visual a modo de un suave movimiento o deslizamiento pleural con la respiración y su presencia descarta el neumotórax.

78. Paciente con SCACEST que tiene que recibir ICP primaria. El tratamiento antiagregante más recomendado es:

- a) AAS 300 mg + Clopidogrel 300 mg.
- b) Prasugrel 60 mg.
- c) Ticagrelor 180 mg + AAS 300 mg.
- d) AAS 100 mg + Clopidogrel 75 mg.

79. Con respecto al tratamiento de la agitación en el Síndrome Confusional Agudo (SCA) en el Adulto:

- a) En el SCA con alteración conductual grave administraremos: Haloperidol 1-5 mg vo..
- b) Administraremos Haloperidol 2,5 – 5 mg cada 30-60 min hasta el control de los síntomas.
- c) Administraremos Haloperidol 2,5 – 5 mg cada 10-20 min hasta el control de los síntomas.
- d) Administraremos Tiapride 100 mg cada 60 min hasta el control de los síntomas.

80. La pauta de fibrinólisis intravenosa con rt-PA (alteplasa) para el código ictus es:

- a) La dosis total es de 1 mg/kg de peso, sin sobrepasar nunca los 60 mg. El 10% se administra en bolo en 1 minuto, y si no aparece reacción alérgica, a los 5 minutos se iniciará la perfusión del resto de la dosis en bomba durante 1 hora.
- b) La dosis total es de 0,9 mg/kg de peso, sin sobrepasar nunca los 90 mg. El 50% se administra en bolo en 1 minuto, y si no aparece reacción alérgica, a los 15 minutos se iniciará la perfusión del resto de la dosis en bomba durante 1 hora.
- c) La dosis total es de 0,9 mg/kg de peso, sin sobrepasar nunca los 90 mg. El 10% se administra en bolo en 1 minuto, y si no aparece reacción alérgica, a los 60 minutos se iniciará la perfusión del resto de la dosis en bomba durante 1 hora.
- d) La dosis total es de 0,9 mg/kg de peso, sin sobrepasar nunca los 90 mg. El 10% se administra en bolo en 1 minuto, y si no aparece reacción alérgica, a los 5 minutos se iniciará la perfusión del resto de la dosis en bomba durante 1 hora.

81. Paciente que a su llegada a urgencias consulta por cefalea, náuseas y vómitos. A la exploración destaca disminución del nivel de consciencia. Tª 36,7°C. PAS 195, PAD 123. FC 87 lpm. Cuál sería el diagnóstico más probable y que tratamiento administrarías:

- a) Crisis hipertensiva, administraría captopril 50 mg. Oral.
- b) Emergencia hipertensiva con afectación renal, administrar nitroprusiato sódico IV.
- c) Emergencia hipertensiva por exceso de catecolaminas, administraría fentolamina y nicardipino IV.
- d) Encefalopatía hipertensiva, administraría labetalol IV.

82. Respecto al uso de Nitroglicerina intravenosa como tratamiento antiisquémico en el SCA (Síndrome Coronario Agudo) señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Indicada cuando el dolor persiste después de haber recibido 3 dosis de NTG (Nitroglicerina) sublingual.
- b) Indicada aunque el dolor haya desaparecido, ante un IAM con IC (Insuficiencia Cardíaca).
- c) Indicada en IAM de VD (Ventrículo derecho).
- d) Indicada en IAM de cara anterior extenso o isquemia persistente con HTA.

83. A la hora de decidir el tratamiento a utilizar en un paciente con taquicardia de QRS ancho estable hemodinámicamente, cuál de los siguientes fármacos evitaría:

- a) Procainamida.
- b) Amiodarona.
- c) Sotalol.
- d) Verapamilo.

84. En cuál de los siguientes procesos evitaría el uso de nitroprusiato:

- a) Edema Agudo de Pulmón secundario a emergencia hipertensiva.
- b) Edema Agudo de Pulmón secundario a cardiopatía isquémica.
- c) Edema Agudo de Pulmón secundario a insuficiencia mitral severa aguda.
- d) Edema Agudo de Pulmón secundario a insuficiencia aórtica severa aguda.

85. Respecto al tratamiento sintomático en la diarrea aguda, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La loperamida está indicada en diarrea moderada-grave en paciente febril.
- b) Los antidiarreicos deben evitarse en la diarrea inflamatoria.
- c) No deben usarse antieméticos de forma sistemática en el tratamiento de la gastroenteritis aguda.
- d) Espasmolíticos como el bromuro de hioscina, 1 comprimido o 1 ampolla cada 6-12 horas, pueden aliviar el cuadro.

86. En relación al tratamiento de una crisis hemorroidal, señala la respuesta INCORRECTA:

- a) Alimentación rica en fibra y laxantes como lactulosa.
- b) Baños de asiento durante 5 minutos con agua muy fría, 2-3 veces al día y después de defecar.
- c) Venotónicos como hidrosmina.
- d) Combinaciones de anestésicos locales, antisépticos y corticoides tópicos en los casos agudos.

87. ¿Qué fármaco está contraindicado para el tratamiento de una crisis tirotóxica aguda?:

- a) Clorpromacina 25 mg / 6 horas iv.
- b) Acetilsalicilato de lisina 900 mg / 8 horas iv.
- c) Dexametasona 2 mg /6 horas iv.
- d) Propranolol 0.5-1 mg iv en bolo.

88. Respecto al tratamiento farmacológico con neurolépticos en el Síndrome confusional agudo, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) El haloperidol es el neuroléptico de elección por su elevada potencia antipsicótica y menos efectos anticolinérgicos.
- b) La levomepromazina es el neuroléptico de mayor acción sedante. Se utiliza a dosis de 25-50 mg. por vía intravenosa, pudiéndose repetir cada 2-4 horas.
- c) La quetiapina puede ser de elección en enfermos parkinsonianos por sus menores efectos extrapiramidales.
- d) Los antipsicóticos atípicos como la olanzapina tienen menor riesgo de prolongación del espacio QT.

89. Acude a urgencias un paciente con carcinomatosis peritoneal con un cuadro de obstrucción intestinal completa. Cuál de las siguientes medidas NO estaría indicada:

- a) Dexametasona 12-16 mg /dosis.
- b) Haloperidol 5-10 mg / dosis.
- c) Metoclopramida 40-240 mg/ dosis.
- d) Butilbromuro de hioscina 60-120 mg/ 24 horas.

90. Señale la falsa respecto a las urgencias y emergencias hipertensivas:

- a) La urgencia hipertensiva se define como la elevación importante de la presión arterial (PA) no asociada a lesiones en órganos diana. En la emergencia hipertensiva hay lesión de órgano diana.
- b) La nitroglicerina es de elección como fármaco parenteral, en la emergencia hipertensiva de origen cardiovascular.
- c) La hidralacina está indicada en la preeclampsia
- d) El labetalol está indicado en la mayor parte de las emergencias hipertensivas: disección de aorta, insuficiencia cardíaca aguda, encefalopatía hipertensiva...

91. Actitud en urgencias del manejo del INR fuera de los rangos normales en pacientes que toman anticoagulantes orales clásicos:

- a) Un INR entre 5-7 sin sangrado requiere suspensión de anticoagulación y ajustar dosis.
- b) Un INR entre 5-7 con sangrado leve requiere suspensión de anticoagulación, administración de 2-4 mg de vitamina K1, antifibrinolíticos locales y control en 24h.
- c) Un INR >7 sin sangrado requiere suspensión de anticoagulación administración de 2-4 mg de vitamina K1 y control en 24h.
- d) Todas son verdaderas.

92. Con respecto al tratamiento de la CAD (Cetoacidosis Diabética), es cierto que:

- a) La reposición hidroelectrolítica es la prioridad absoluta.
- b) La corrección de la acidosis se logra administrando Bicarbonato.
- c) La hiperpotasemia es la principal causa de muerte evitable.
- d) La perfusión de insulina se suspenderá con cifras de glucemia < 250 mg/dl.

93. Ante un cuadro de disnea de instauración aguda con la sospecha de que su origen sea un cuadro insuficiencia cardíaca (IC), la determinación en plasma del NT-proBNP tiene utilidad diagnóstica y pronóstica. Señale la respuesta correcta:

- a) Un ECG normal y unas concentraciones de NT-proBNP < 30 pg/mL sugieren que la etiología sea cardiológica.
- b) Un ECG normal y unas concentraciones de NT-proBNP < 30 pg/mL sugieren que la etiología no sea la insuficiencia cardíaca (IC improbable)
- c) Un ECG normal y unas concentraciones de NT-proBNP > 300 pg/mL sugieren que la etiología no sea la insuficiencia cardíaca (IC improbable)
- d) Un ECG anormal y unas concentraciones de NT-proBNP > 300 pg/mL sugieren que la etiología no sea la insuficiencia cardíaca (IC improbable)

94. Según el territorio vascular afectado, el AIT se clasifica en carotideo, vertebrobasilar e indeterminado y en función de sus manifestaciones clínicas puede ser: Uno de los siguientes no es cierto.

- a) Típico.
- b) Retiniano
- c) Hemisférico cortical.
- d) Lacunar.

95. En relación con el abordaje de la insuficiencia respiratoria aguda en urgencias ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$), cuando el mecanismo de producción es un shunt arteriovenoso, esperaríamos encontrar:

- a) PaO_2 baja o disminuida, PaCO_2 baja y el gradiente alveolo-arterial de oxígeno $[\text{P(A-a)O}_2]$ bajo
- b) PaO_2 baja o disminuida, PaCO_2 elevada y el gradiente alveolo-arterial de oxígeno $[\text{P(A-a)O}_2]$ elevado
- c) PaO_2 baja o disminuida, PaCO_2 baja y el gradiente alveolo-arterial de oxígeno $[\text{P(A-a)O}_2]$ elevado
- d) PaO_2 normal, PaCO_2 elevada y el gradiente alveolo-arterial de oxígeno $[\text{P(A-a)O}_2]$ elevado

96. La pentada de Reynolds en la colangitis incluye:

- a) Dolor en hipocondrio derecho + fiebre + ictericia + confusión mental + insuficiencia renal.
- b) Dolor en hipocondrio derecho + fiebre + ictericia + insuficiencia renal + shock.
- c) Dolor en hipocondrio derecho + fiebre + ictericia + confusión mental + shock.
- d) Fiebre + ictericia + dolor en hipocondrio derecho + insuficiencia respiratoria + shock.

97. En la exploración vestibular del cuadro vertiginoso periférico, junto con el nistagmo, se realiza la Prueba de indicación de Barany, que mide la lateralización de los miembros superiores del paciente al tener los brazos extendidos con dedos flexionados excepto los índices, y haciendo subir y bajar los mismos repetidamente con los ojos cerrados. Es cierto que:

- a) En alteraciones centrales se produce una desviación de ambos índices simétricamente hacia el lado de la lesión, armónica con la fase lenta del nistagmo. En alteraciones laberínticas, se puede producir una desviación hacia el otro lado.
- b) En alteraciones laberínticas se produce una desviación de ambos índices simétricamente hacia el lado contrario de la lesión, armónica con la fase lenta del nistagmo. En alteraciones centrales, se puede producir una desviación hacia el mismo lado.
- c) En alteraciones laberínticas o centrales se produce una desviación de ambos índices simétricamente hacia el lado de la lesión, armónica con la fase lenta del nistagmo. Cuando no hay ninguna alteración, se puede producir una desviación hacia el otro lado.
- d) En alteraciones laberínticas se produce una desviación de ambos índices simétricamente hacia el lado de la lesión, armónica con la fase lenta del nistagmo. En alteraciones centrales, se puede producir una desviación hacia el otro lado.

98. En la taquicardia ventricular:

- a) Cuando hay ondas "P" no suelen tener relación fija con los complejos QRS.
- b) El ritmo es siempre irregular.
- c) La frecuencia cardíaca es siempre superior a 200 latidos por minuto.
- d) Nunca puede haber ondas "P"

99. En un paciente con patología ORL, consideraremos como cierto que:

- a) La otitis externa se caracteriza por otalgia y fiebre con eritema de conducto auditivo externo.
- b) La otitis media se caracteriza por fiebre alta.
- c) El tratamiento de la laberintitis consiste en antibioterapia IV y drenaje quirúrgico.
- d) Las respuestas (a) y (c) son ciertas.

100. En pacientes portadores de DAI (desfibrilador automático implantable), señale cuál es la arritmia que con mayor frecuencia origina descargas múltiples inapropiadas:
- a) Taquicardia ventricular polimórfica.
 - b) Fibrilación auricular.
 - c) Taquicardia incesante de la unión AV.
 - d) Flutter auricular.
101. No se incluye entre los síntomas lacunares:
- a) Ataxia- hemiparesia.
 - b) Hemianopsia homónima.
 - c) Síndrome sensitivo puro.
 - d) Hemiparesia motora pura.
- 102.Cuál de estos fármacos NO tiene una asociación confirmada con la Pancreatitis Aguda:
- a) Cisplatino.
 - b) Mesalazina.
 - c) Furosemida.
 - d) Estrógenos.
103. En la actualidad y para ser utilizada en los servicios de urgencias como alternativa a los criterios de Ranson en la pancreatitis aguda (PA), se utiliza la escala de BISAP. Solo uno de los criterios señalados es correcto y se valora en la citada escala:
- a) Edad > 80 años.
 - b) Existencia de derrame pleural.
 - c) LDH > 400 UI/L.
 - d) Glucosa > 250 mg/dl.
104. Acude un paciente a urgencias con deformidad a nivel humeral, la muñeca está en flexión palmar sin movilidad y con pérdida de sensibilidad en la piel del dorso de la mano entre el 1º y 2º dedo. ¿A qué nivel está la fractura y que nervio está afectado?:
- a) Fractura de 1/3 medio de húmero y radial.
 - b) Fractura supracondilea y mediano.
 - c) Fractura de 1/3 proximal de húmero y radial.
 - d) Fractura de 1/3 distal de húmero y mediano.
105. En la valoración de un síndrome febril en urgencias se debería considerar la indicación de ingreso (al menos en observación de urgencias) y la extracción de hemocultivos si:
- a) La procalcitonina es > 100 mg/ml
 - b) La procalcitonina es de 0,1-0,5 ng/ml
 - c) La procalcitonina es > 5 mg/ml
 - d) La procalcitonina es > 1 ng/ml